

EJERCICIO PRÁCTICO EN EL PROCESO DE PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN PSICÓLOGA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

EJERCICIO PRÁCTICO (TIPO TEST)

SUPUESTO PRÁCTICO 1

Antonio acaba de conseguir una plaza de psicología en la Diputación de Jaén, se ha incorporado a uno de los Centro de Servicios Sociales Comunitarios de esta Diputación.

Recientemente ha acudido a los Servicios Sociales Comunitarios de su municipio Marta de 45 años, acude solicitando apoyo. Vive con sus dos hijos, Ana y Juan de 9 y 14 años y con su madre Carmen de 74 años, que tiene movilidad reducida y está en proceso de valoración de dependencia. Marta tiene un hijo de una relación anterior, Pedro, de 19 años, que se encuentra viviendo en una Residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas de la Provincia

La familia atraviesa una situación de conflicto intrafamiliar y violencia de género ejercida por la pareja de Marta, que actualmente convive en el domicilio, Marta refiere que su marido consume alcohol y sospecha que quizás alguna otra sustancia. Ella presenta síntomas de ansiedad y sentimientos de baja autoestima. Aunque reconoce sufrir maltrato psicológico y físico, aún no ha interpuesto denuncia.

En la primera entrevista, se detectan varios indicadores preocupantes en la/el menor:

Ana, la hija menor, muestra conductas impulsivas y agresividad con sus compañeros de colegio, además de dificultades para mantener la atención.

Javier, el hijo mayor, ha presentado descenso en el rendimiento escolar, aislamiento social y episodios de retraimiento.

Dada la complejidad del caso, la situación de riesgo del núcleo familiar y la vulnerabilidad de algunos/as de los/as miembros de la Unidad Familiar. El equipo interdisciplinar del que forma parte Antonio, comienza la valoración del caso presentado.

1. Según la ley Orgánica 1/1996, 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 12) relativo a las actuaciones de protección, cualquier medida de protección NO permanente.

- a) Se revisará cada año si se adopta respecto de menores de tres años.
- b) Se revisará cada seis meses si se adopta respecto de mayores de tres años.
- c) Se revisará cada cinco meses si se adopta respecto de mayores de tres años.
- d) Se revisará cada seis meses si se adopta respecto de menores de tres años.

2. Según la ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en su art. 26 sobre Prevención de violencia en el ámbito familiar. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o divorcios.
- b) No deben adoptarse medidas para la imposición de la custodia compartida no acordada.
- c) Debe tenerse en cuenta las situaciones donde exista el síndrome de alienación parental
- d) Las medidas deben promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el buen trato prenatal.

3. Según la ley 4/2021 de 27 de julio, de infancia y adolescencia en Andalucía. (art 69) Las administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones para fomentar la parentalidad positiva, dirigidas hacia la población en general, basada en las necesidades y derechos de la infancia y adolescencia.

- a) Con un enfoque eficiente, equitativo, intersectorial y ecológico, atendiendo a la diversidad.
- b) Con un enfoque eficaz, equitativo, intersectorial y atendiendo a la diversidad.
- c) Con un enfoque preventivo, positivo, equitativo, intersectorial y ecológico, atendiendo a la diversidad.
- d) Con un enfoque equitativo, intersectorial y atendiendo a la diversidad, que fomente el empoderamiento de los menores.

4. Son criterios inspiradores de las actuaciones en el III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía.

- a) Visión, misión y valores estratégicos.
- b) Visión, equidad e implicación intersectorial.
- c) Participación, integralidad y excelencia.
- d) Equidad, integralidad y participación.

5. Antonio, propone al Equipo de Intervención Familiar, diseñar un proyecto para el desarrollo de competencias personales para trabajar con algunos miembros de familias del P.I.F (Programa Intervención Familiar) tomando como referencia el Modelo de Competencia Social de Gumpel, este modelo engloba 6 áreas claves entre las que NO se encuentra:

- a) Habilidades de decisión.
- b) Juicios de monitorización personal.
- c) Habilidades de decodificación.
- d) Habilidades de introspección

6. El psicólogo del Equipo de Intervención Familiar en una reunión con sus compañeros/as recuerda que la alianza de trabajo es una clave esencial del éxito de la intervención. Basándose en las 4 dimensiones del modelo S.O.A.T.I.F (Sistema de Observación de la Alianza Terapéutica en la Intervención Familiar). “Guía práctica para la intervención familiar” (Valentín Escudero) SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Reconocimiento del sistema familiar.
- b) Conexión emocional del usuario/a con el/la profesional
- c) Seguridad en el sistema de intervención
- d) Sentido de compartir el propósito en la familia

7. Antonio propone revisar las estrategias de empoderamiento de la alianza con familias para casos difíciles (Valentín Escudero) con objeto de fomentar la alianza terapéutica con la familia de Marta. Considerando esas estrategias, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Crear una “comunidad de afectados”.
- b) Aclarar quién es el cliente.
- c) Evitar trabajar en el hogar de la familia.
- d) Transmitir optimismo.

8. Es frecuente en el trabajo con familias que los equipos de intervención familiar se encuentren con dificultades o patologías relacionadas con la salud mental y adicciones. Marta, madre de 3 hijos (2 menores y uno con una grave discapacidad) presenta síntomas de ansiedad. En la clasificación de los trastornos de ansiedad, según el manual DSM-5, en el trastorno de ansiedad por separación, se establece: SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) La característica esencial del trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva ante el alejamiento del hogar o de las personas a quienes el sujeto está vinculado. (Criterio A)
- b) Esta alteración suele mantenerse durante un periodo de al menos 4 meses en los niños y adolescentes menores de 18 años, y normalmente dura 6 meses o más en los adultos. (Criterio B)
- c) El trastorno de ansiedad por separación en los niños puede estar asociado con un riesgo mayor de suicidio.

- d) En los niños, el trastorno de ansiedad por separación es muy comórbido con el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia específica.

9. El equipo interdisciplinar del que forma parte Antonio, se plantea iniciar un Programa de Intervención Familiar con la familia de Marta. Para ello revisan el manual vigente en la Diputación de Jaén, donde dicho P.I.F se define como un programa con los siguientes criterios: SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Específico de prevención secundaria.
- b) Intervención integral, específica, planificada y consensuada.
- c) Dirigido a familias vulnerables en situación de riesgo leve y moderado.
- d) Uno de los objetivos es trabajar la reunificación familiar.

10. En la fase de presentación del programa P.I.F, cuando la familia no acepta su inclusión, el Equipo de Intervención Familiar trabajará la causa de la negativa intentando reducir las resistencias, durante el tiempo que estime necesario. ¿Cuál es la intervención que procede con el objetivo de despertar conciencia y motivación al cambio? SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Ante la posición de la familia “son los otros”, la directriz profesional es analizar el nivel inconsciente.
- b) Ante la posición de la familia “ya hemos hecho todo” la directriz profesional es trabajar atribución de tareas y mentalización.
- c) Ante la posición de la familia no consciente, disociación; la directriz profesional es analizar el nivel inconsciente, devolver control, contexto de trauma.
- d) Ante la posición de la familia “no entiendo esa necesidad” la directriz básica para el /la profesional es educar, apoyar, valorar la limitación de la familia.

11. Marta vive con sus hijos, de 9 y 14 años. En la primera entrevista, se detectan varios indicadores preocupantes en la/el menores. Considerando el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de infancia y adolescencia en Andalucía, VALÓRAME. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) La presencia de conciencia del problema y/o colaboración con la propuesta de intervención no supondrá una disminución en el nivel de global de gravedad
- b) La nula o insuficiente conciencia del problema y/o colaboración con la propuesta de intervención no podrá suponer un incremento en la valoración del nivel de gravedad del caso.
- c) La presencia de indicadores de riesgo leve sin que existan indicadores de gravedad moderada, elevada o muy elevada, supondrá la valoración global como riesgo de desprotección.
- d) Salvo excepciones debidamente argumentadas, la presencia simultanea de varios indicadores de gravedad moderada no incrementa el nivel de gravedad global del caso.

12. Respecto al instrumento VALÓRAME, además de valorar el tipo principal de desprotección, siempre valoraremos la posible presencia de:

- a) Maltrato psicológico y abandono.
- b) Negligencia y maltrato físico.
- c) Abuso sexual y abandono.
- d) Maltrato psicológico y negligencia.

13. Antonio, como psicólogo del Equipo, propone utilizar además del VALORAME, el cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) de Goodman (1997).

- a) Los cuestionarios de autoinforme para adolescentes contienen preguntas sobre 20 atributos, esta versión es adecuada para jóvenes de entre 11 y 16 años, dependiendo de su nivel de alfabetización y comprensión.
- b) Para la población general o de bajo riesgo psicosocial puede ser mejor utilizar una alternativa que divide en tres subescalas el SDQ: problemas internalizados, síntomas de externalización y síntomas emocionales.
- c) Algunas de las versiones disponibles del SDQ contienen al final un suplemento del impacto que generan los problemas detectados.
- d) La suma de las puntuaciones de las escalas: síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, falta de atención, y comportamiento prosocial generará una puntuación total de dificultades (basada en 25 ítem).

14. Antonio, propone a sus compañeros de Equipo, revisar los diferentes modelos de apego infantil, según el grado de competencias parentales. Según Jorge Barudy, considerando las incompetencias parentales y los apegos inseguros infantiles, el apego evitativo se caracteriza por:

- a) Los progenitores emocionalmente inaccesibles o reactivos, no perceptivos, se vinculan de un modo inseguro a sus hijos/as y los niños y niñas en la “situación extraña” parecen ignorar la reaparición de sus progenitores.
- b) Cuando los progenitores son incoherentes y negligentes a la hora de responder a las señales de sus hijos/as, estos/as en la “situación extraña” aparecen ansiosos, difíciles de tranquilizar con la vuelta de los progenitores.
- c) En progenitores que emiten a sus hijos/as mensajes amenazantes, confusos o amedrentadores, durante la prueba de la “situación extraña”, tanto cuando están con el progenitor como cuando sale o vuelve, los niños/as se comportan agitadamente, parecen no escuchar las ordenes o consignas, “quedarse como congelados o paralizados”.
- d) Cuando los progenitores intentan imponer sus propios estados mentales, siendo incoherentes y negligentes, se produce en los hijos/as una “sobreactivación del sistema de apego”.

15. Antonio como psicólogo, ha de conocer que según la Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en su artículo 28, existirá:

a) La reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 15% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

b) La reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

c) La reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

d) La reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 2% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

16. Antonio (psicólogo) debe conocer también que según la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las personas mayores, son centros de participación activa:

a) Aquellos centros destinados a prestar una atención integral durante parte del día a personas mayores con un grado variable de dependencia física o psíquica.

b) Aquellos destinados a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal y se configuran como pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas.

c) Los centros de promoción de bienestar de las personas mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población.

d) Centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se presta a la persona mayor una atención integral.

17. Con Pedro se está trabajando con el Modelo de Atención Centrada en la Persona. Dicho modelo NO persigue:

- a) La participación de la persona, su familia o sus personas allegadas, en su plan de atención y vida.
- b) Que las características de las actividades terapéuticas que se realicen con las personas sean significativas.
- c) La constitución de grupos de apoyo, incluidos profesionales de atención directa.
- d) Ver a la persona como el conjunto de enfermedades, necesidades y déficits que presenta.

18. En el caso de que Carmen, de 74 años, viviese en un centro residencial, un buen Plan de Atención Individualizada NO debe concebirse como:

- a) Proceso continuo, dinámico, que se va adaptando a las necesidades de la persona en cada momento.
- b) Un plan abierto y participativo, instrumento de diálogo entre la persona, la familia y los profesionales que conforman el equipo.
- c) Un proceso en el que los miembros del equipo interdisciplinar establecen las prioridades de intervención, cada uno desde su área de trabajo.
- d) Plan integral, que debe satisfacer todas las necesidades de la persona, teniendo en cuenta sus deseos y preferencias y su proyecto de vida.

19. Para la valoración cognitiva de las personas residentes con discapacidad, y/o mayores, contamos con numerosos tests o escalas. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- a) Escala de Barthel.
- b) Cuestionario de Pfeiffer.
- c) Mini examen cognoscitivo de Blessed.
- d) Escala de Lawton y Brodie.

20. En la residencia donde vive Pedro, la persona trabajadora que conoce las necesidades, preferencias, deseos de la persona con discapacidad, intentando que sus expectativas sean satisfechas para favorecer su bienestar, y que interviene activamente en el Plan Personal de Apoyos, en las reuniones para su diseño, seguimiento e implantación, sirviendo de cauce de comunicación de la persona usuaria con el equipo interdisciplinar, es:

- a) El/la psicólogo/a.
- b) El /la profesional de referencia.
- c) El equipo interdisciplinar.
- d) El personal de atención directa.

21. La calidad de vida en las personas con discapacidad intelectual, según el modelo teórico propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003) está compuesta por las siguientes 8 dimensiones:

- a) Bienestar emocional, bienestar material, bienestar económico, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos.
- b) Bienestar económico, bienestar físico, bienestar familiar, desarrollo personal, relaciones interpersonales, inclusión social, autodeterminación y derechos.
- c) Bienestar emocional, abordaje multidisciplinar, bienestar material, bienestar físico, derechos, inclusión social, desarrollo personal y autodeterminación.
- d) Bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos.

22. Uno de los objetivos del Modelo de Atención centrada en la persona, es la no utilización de los medios de contención mecánica o sujeciones físicas en los centros residenciales. Según la Guía de cuidados sin sujeciones, de la Sociedad Española de Geriátrica y Gerontología (2023), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los programas de eliminación de sujeciones han demostrado que se pueden conseguir centros libres de contenciones y que son más seguros, no habiendo mayor riesgo de caídas ni mayor riesgo de alteraciones conductuales.
- b) Conseguir su implantación no implica necesariamente cambiar principios fundamentales de la organización y estructura de los servicios.
- c) Con el objetivo de mantener la no sujeción a lo largo de toda la cadena de cuidado, se compartirán criterios asistenciales comunes en cuanto a prescripción, autorización, consentimiento, metodología de aplicación y cuidados complementarios.
- d) Se ha comprobado que sólo la formación no ha servido para cambiar el uso de sujeciones, ya que los principales determinantes del uso de contenciones y de su normalización no son de carácter técnico, sino de mentalidad, organizativos, socioculturales y sobre todo, de actitud.

23. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, NO es cierto que:

- a) Entre los síntomas psicológicos y conductuales pueden estar: apatía, desinhibición, euforia, disforia, irritabilidad, delirios.
- b) La progresión típica de la enfermedad es: pérdida de memoria, pérdida de funciones ejecutivas, pérdida de funciones visoespaciales, pérdida de lenguaje.
- c) El tratamiento farmacológico más utilizado es: donepezilo, rivastigmina, galantamina y terbinafina.
- d) El tratamiento no farmacológico incluye: talleres de psicoestimulación, reminiscencia, arteterapia, salas snoezelen, psicomotricidad, musicoterapia.

24. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la elaboración del Plan Personal de Apoyos?. Señale la opción INCORRECTA:

- a) Planificar apoyos acorde a las expectativas de la persona con discapacidad.
- b) Conseguir la participación real de la persona en las decisiones sobre su vida.
- c) Asegurar que los aspectos relacionados con la salud sean preferentes a cualquier otro aspecto de su vida.
- d) Establecer pautas de actuación ajustadas a la realidad concreta.

25. En los centros que atienden a personas como Pedro, y siguiendo el modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial de personas con necesidades complejas de apoyo, es común la existencia de instrumentos como el Comité de Ética Asistencial. ¿Cuál es la definición de este comité?:

- a) Instrumento que permite compartir un sistema de trabajo y de vida cotidiana desde una perspectiva de los valores éticos de la institución.
- b) Instrumento que debe mencionar los derechos básicos de las personas usuarias, su significado y la necesidad de que sean el fundamento de la atención residencial.
- c) Instrumento que ayuda a identificar situaciones de riesgo y a promover formas de actuar fundamentadas en los principios éticos de la entidad que cubre las necesidades de apoyo.
- d) Instrumento que cuenta con equipos interdisciplinarios que dentro de una institución, reciben oficialmente el encargo de aconsejar a los profesionales y directivos en sus decisiones sobre cuestiones éticas planteadas en la práctica.

26. Según el artículo 45 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, sobre los Ingresos en centros residenciales, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Ninguna persona mayor podrá ser ingresada en un centro, sin que conste fehacientemente su consentimiento. En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial para el ingreso.
- b) Los responsables de centros residenciales que advirtieren en una persona mayor ingresada la concurrencia sobrevenida de circunstancias determinantes de su incapacitación, deberán ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección.
- c) Ninguna persona mayor podrá ser obligada contra su voluntad a permanecer en un centro residencial, salvo en los supuestos en que medie resolución judicial.
- d) Los servicios de inspección velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores e, igualmente, podrán solicitar del interesado que ratifique la voluntariedad de su estancia, mediante entrevista personal mantenida sin la presencia de familiares ni de representantes del centro.

27. En el Plan de Apoyo Conductual Positivo elaborado para Pedro:

- a) Los desencadenantes rápidos de una conducta son los factores que nos van influyendo y cambiando el humor, molestándonos o poniéndonos nerviosos.
- b) El desencadenante lento es aquello que ocurre inmediatamente antes de que ocurra la conducta que nos preocupa. Son las causas o factores que nos hacen perder el control.
- c) Identificamos los indicadores de desregulación de la conducta, que son signos siempre fisiológicos que nos indican que se está perdiendo el control.
- d) Es muy importante tener en cuenta el ciclo de conducta, el cual se asemeja a un semáforo: en verde señalamos el estado de la persona cuando está feliz y tranquila. En ámbar registramos el estado en que se encuentra la persona cuando comienza a desregularse, y en rojo la persona se encuentra en situación crítica.

28. En cuanto al envejecimiento normal (no patológico):

- a) Los mayores no muestran mayor enlentecimiento general durante las tareas atencionales que los sujetos más jóvenes. (Vázquez-Marrufo et al. 2010).
- b) En relación a la velocidad de procesamiento de la información, durante la vejez habitualmente no aparece enlentecimiento. (Salthouse, 1991).
- c) El lenguaje es una capacidad que permanece conservada de manera general, sin olvidar que es una variable ligada a factores como el nivel educacional. (Montañés et al. 2007).
- d) Respecto a la atención dividida, se produce un aumento en el rendimiento de tareas duales. (Madden, 1990).

29. Antonio, tras evaluar la interacción de Marta con su hija Ana, decide aplicar la técnica del modelado de conducta:

- a) El feedback y el refuerzo se emplean de forma consecutiva al ensayo conductual con el fin de moldear las conductas de los sujetos
- b) Se expone al paciente a un modelo que muestre correctamente la conducta que está siendo objetivo de reforzamiento.
- c) La forma habitual para extinguir comportamientos inadaptados es no prestar atención
- d) La aplicación del refuerzo tiene como finalidad principal proveer a los sujetos de la motivación necesaria para que mejoren sus comportamientos y mantengan los logros que han conseguido.

30. ¿Qué instrumento podría utilizar Antonio para valorar si el consumo del marido de Marta es problemático?

- a) CAGE
- b) Test de Fagestrom
- c) Mini-mental test
- d) IPDE

31. En la entrevista que Antonio tiene con Marta y su marido, trata el consumo abusivo de alcohol de la pareja y la posibilidad de derivar al Centro de Tratamiento de Adicciones, según el modelo de Prochanska y Diclemente: una persona “cuando es consciente de que existe un problema y considera abandonar la conducta adictiva en los próximos meses, pero todavía no ha desarrollado un compromiso firme para el cambio”, se encontraría en el siguiente estadio de cambio:

- a) Precontemplación.
- b) Contemplación
- c) Preparación
- d) Recaída

32. Antonio le da unas pautas generales a Marta y a su pareja respecto al abuso de alcohol. En la atención psicológica de las personas con adicciones, ¿Qué es el manejo de contingencias?

- a) Un programa de reforzamiento mediante uso exclusivo de refuerzos positivos
- b) Es la aplicación sistemática de reforzadores o castigos contingentes a la ocurrencia de la conducta objetivo, o a la ausencia de la misma, que compite con los efectos reforzantes de las drogas.

- c) Es un programa que demuestra que el uso de las drogas es una conducta operante
- d) Es un programa para enseñar habilidades de afrontamiento.

33. Antonio, se entrevista con el tutor de Javier. El tutor le comenta que sería necesario realizar actividades de prevención en el Instituto. El Programa Ciudades ante las Drogas es un referente de la prevención comunitaria en la Comunidad Autónoma Andaluza, cuyos objetivos son:

- a) Implicar a las Corporaciones Locales.
- b) Obtener subvenciones para realizar actividades comunitarias.
- c) Reducir el uso y/o abuso de drogas, implicando a la población y la disminución de los riesgos asociados al consumo en jóvenes consumidores ocasionales, así como en colectivos de mayor riesgo.
- d) Desarrollar proyectos de prevención en el ámbito educativo.

34. Realizar una encuesta a diferentes grupos de edad del Instituto para comparar sus hábitos de ocio sería:

- a) Un estudio longitudinal y observacional.
- b) Un estudio transversal y observacional.
- c) Un estudio longitudinal.
- d) Experimental.

35. Un estudio de casos es un tipo de investigación:

- a) Descriptiva.
- b) Experimental.
- c) Correlacional.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

36. Antonio, detecta la necesidad de trabajar la parentalidad positiva con Marta y su marido. Según el art. 81 de la Ley 4/2021 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía:

- a) Se promoverán actuaciones preventivas y reparadoras que potencien los factores protectores de las familias, procurando la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su desarrollo personal, en cuyo caso se les proporcionará la alternativa familiar más adecuada.
- b) Se priorizará la adopción de medidas familiares frente a las residenciales, las temporales frente a las estables, y las consensuadas frente a las impuestas, garantizando la continuidad de las relaciones personales con su familia de origen y su familia extensa, siempre que no vaya en contra de su interés superior, perjudique su desarrollo integral, ni la adopción de una medida estable.
- c) La existencia de relaciones personales de la niña, niño o adolescente con su familia de origen podrá ser un impedimento para una posible propuesta de guarda con fines de adopción.
- d) Se protegerá el acceso a la información sobre los orígenes biológicos a las personas que hayan sido adoptadas, incluso si son menores de edad.

37. Antonio realiza una evaluación sobre los síntomas de ansiedad de Marta. ¿Qué tipo de variable es el nivel de ansiedad?

- a) Ordinal o Cuantitativa.
- b) Discontinua.
- c) Dicotómica.
- d) Demográfica.

38. Antonio le plantea a Marta que pida cita para Ana en Salud Mental Infantil con objeto de realizar un diagnóstico sobre un posible TDHA. NO es criterio de hiperactividad e impulsividad:

- a) Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado.
- b) Muestra una hostilidad pronunciada hacia los otros.
- c) Con frecuencia habla excesivamente.
- d) Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.

39. ¿Qué características presenta el trastorno negativista desafiante según el DSM 5?

- a) Enfado, irritabilidad, discusión, actitud desafiante y vengativa.
- b) Dura al menos tres meses.
- c) Esta conducta se da con un hermano.
- d) Esta conducta no causan deterioro en el funcionamiento social.

40. Antonio, como parte del equipo interdisciplinar que intervendrá en el caso expuesto, es esencial que conozca los principios rectores establecidos en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que orientan la actuación profesional dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. De acuerdo con esta Ley, el Sistema Público de Servicios Sociales se regirá por el principio rector de:

- a) Beneficencia unilateral.
- b) Atención centrada en la persona y en su contexto.
- c) Garantía asistencial, respuesta contingente a las necesidades presentadas.
- d) Eficiencia profesional, social y económica.

41. El quipo Interdisciplinar informa a Marta que, en el proceso de valoración de dependencia de su madre, tiene derecho a elegir entre diferentes servicios o prestaciones que se ajusten a sus necesidades y preferencias de acuerdo con la normativa vigente. Según el artículo 3 de la Ley 39/2006, de 24 de diciembre ¿Qué principio básico de la Ley 39/2006 se aplica al reconocerle la posibilidad de elegir entre distintos servicios o prestaciones dentro de su PIA?.

- a) La sostenibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia considerando relación entre el coste/beneficio del servicio.
- b) Principio de libre concurrencia en el acceso a recursos y servicios que ofrece el catálogo de prestaciones.
- c) La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.

d) Principio de voluntariedad, sin condicionantes.

42. Antonio decide utilizar una técnica de entrevista funcional en este caso. Para ello realiza un análisis de la conducta utilizando el modelo A-B-C (Antecedente-Conducta-Consecuencia) para registrar y analizar las variables que rodean una conducta problemática. ¿Cuál de las opciones describe el elemento esencial que ha de ser indagado por Antonio en esta entrevista funcional?

- a) La historia de aprendizaje de la persona entrevistada.
- b) Los antecedentes, identificando únicamente el contexto en que se produce, las personas intervinientes y las consecuencias provocadas en el entorno.
- c) Antecedentes, qué ocurre antes de la conducta, descripción clara y objetiva de la conducta problema y consecuencias.
- d) La historia de vida de la persona, identificando el punto de inicio de la conducta problema.

43. De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la naturaleza y el ámbito subjetivo de la violencia que constituye el objeto de dicha norma?

- a) Se produce exclusivamente en la relación de pareja.
- b) La violencia que se ejerce sobre las mujeres como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
- c) Requiere siempre convivencia para ser reconocida.
- d) Es un delito leve de carácter privado.

44. El Equipo Interdisciplinar que está interviniendo donde Antonio es el Psicólogo, subraya la importancia de identificar el patrón de abuso para el diseño del plan de seguridad y el apoyo emocional a Marta. Antonio hace referencia al modelo clásico de Leonore Walker (1979) para describir la secuencia de maltrato. Según este modelo, ¿cuál es la denominación y el orden correcto de las tres fases que componen el ciclo de la violencia?

- a) Agresión → Denuncia → Reconciliación.
- b) Acumulación de tensión → Explosión violenta → Luna de miel.
- c) Control coercitivo → Dependencia emocional → Sumisión.
- d) Humillación → Castigo físico → Reconciliación.

45. El equipo interdisciplinar ha detectado indicadores conductuales y cognitivos que sugieren la presencia de un Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia (SAPV). ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se considera el eje central y característico del SAPV, siendo crucial para el diagnóstico diferencial y la formulación del plan de intervención psicosocial?

- a) Negación persistente del riesgo y minimización del impacto de las agresiones, junto con el desarrollo de un vínculo de lealtad o dependencia hacia el agresor.

- b) Hiperactivación autonómica sostenida (hipervigilancia), fenómenos de *flashbacks* e intensa reactividad fisiológica al recuerdo del trauma, propios del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).
- c) Sintomatología psicótica grave, como alucinaciones de comando o delirios de perjuicio sistematizados, que requieran una intervención psiquiátrica inmediata.
- d) Patrón de conducta antisocial mantenida, caracterizado por impulsividad, transgresión normativa y ausencia de remordimiento.

46. Antonio, como psicólogo en el equipo interdisciplinar que atiende este caso, debe valorar la situación de la hija expuesta a violencia de género en el ámbito doméstico. Para garantizar la protección efectiva y minimizar el daño iatrogénico, el equipo debe ser consciente de las prácticas que generan revictimización. ¿En cuál de los siguientes escenarios se materializa la victimización secundaria para la menor expuesta a la violencia?

- a) Cuando los/as profesionales de las distintas administraciones que interviene minimizan, deslegitiman o exigen una narración repetitiva y no mediada del trauma, obligando a la niña a confrontar su experiencia sin las garantías de contención emocional y respeto procesal.
- b) Cuando la menor es derivada a un programa de intervención terapéutica focalizada en trauma, recibiendo atención especializada e inmediata y desarrollando estrategias de *coping* adaptativo.
- c) Cuando, en el proceso judicial, se utiliza un espacio amigable (Sala Gesell), se garantiza la confidencialidad de sus datos y se prioriza su seguridad frente al agresor.
- d) Cuando, a pesar de la exposición a la violencia, la menor desarrolla mecanismos resilientes que le permiten un ajuste emocional funcional.

47. Para la exploración exhaustiva y estandarizada de la sintomatología de la hija menor de Marta expuesta a la violencia de género, ¿cuál de los siguientes instrumentos de evaluación psicométrica está específicamente diseñado y más recomendado para identificar las secuelas postraumáticas en esta población?

- a) Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC)
- b) Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)
- c) Test de Apercepción Temática (TAT)
- d) Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS)

48. En el marco de la evaluación neuropsicológica, si Antonio decide utilizar las Matrices Progresivas de Raven, ¿cuál es el objetivo psicométrico principal de este instrumento?

- a) Evaluar la eficiencia de la memoria de trabajo y la capacidad para codificar información verbal a largo plazo.
- b) Medir la capacidad de razonamiento abstracto, la deducción de relaciones y la resolución de problemas nuevos, con la menor influencia posible del conocimiento escolar y la cultura (Inteligencia Fluida).
- c) Valorar las habilidades lingüísticas complejas, el *output* narrativo y la riqueza del vocabulario como indicadores de Inteligencia Cristalizada.
- d) Analizar el estilo de afrontamiento emocional y la presencia de conflictos interpersonales mediante el análisis de narrativas proyectivas.

49. El equipo interdisciplinar ha detectado que la eficacia del liderazgo de la persona que coordina es variable y depende en gran medida del nivel de competencia y compromiso de cada persona del equipo. Desde la perspectiva de la Teoría del Liderazgo Situacional (TLS) de Hersey y Blanchard, ¿cuál es el postulado fundamental que determina la efectividad de la persona líder en la gestión de equipos de alto rendimiento como el interdisciplinar?

- a) La efectividad reside en la aplicación consistente de un estilo directivo (autocrático), ya que proporciona la estructura necesaria para un equipo profesional.
- b) La efectividad del líder radica en su capacidad para diagnosticar el nivel de madurez de las personas que integran el equipo y adaptar flexiblemente su estilo de liderazgo a dichas situaciones cambiantes.
- c) La efectividad se basa en la adopción de un estilo puramente transaccional (administrativo), centrado exclusivamente en el cumplimiento de tareas y recompensas.
- d) La efectividad se define por el uso inalterable de un estilo participativo (democrático) que fomente permanentemente el consenso y la autonomía.

50. En el marco de esta intervención comunitaria, Antonio decide implementar técnicas de diagnóstico participativo (como el Mapa de Recursos o el Sociograma de Moreno). ¿Cuál es el objetivo primordial de estas técnicas desde la Psicología Comunitaria?

- a) Promover la introspección profunda y el autoconocimiento en las personas participantes clave del proyecto.
- b) Identificar las redes informales de apoyo social, las personas líderes naturales y la estructura de las relaciones interpersonales existentes dentro de la comunidad o grupo.
- c) Evaluar el nivel de competencia cognitiva y el cociente intelectual promedio de las personas que forma parte de la comunidad para determinar su capacidad de autogestión.
- d) Medir exclusivamente el rendimiento productivo o la eficiencia de las tareas del grupo en función de objetivos preestablecidos.

RESERVAS

51. Según el Código Deontológico del Colegio de Psicólogos, en el proceso de evaluación e intervención o tratamiento, SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) Cuando una determinada evaluación o intervención psicológica envuelva estrechas relaciones con otras áreas disciplinares y competencias profesionales, el/la Psicólogo/a tratará de asegurar las correspondientes conexiones, bien por sí mismo, bien indicándoselo y orientando en ese sentido al cliente.
- b) Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de intervención o tratamiento, queda reservado al uso de los/as Psicólogos/as, que se abstendrán de facilitarlos a otras personas no competentes.
- c) Sin perjuicio del derecho del paciente a la libre elección de psicólogo en los términos ya establecidos, no corresponde al nuevo Psicólogo/a designado valorar las intervenciones iniciadas por otros psicólogos.

- d) El paciente tendrá plena libertad para concertar los servicios profesionales de un psicólogo/a y para resolver dicha intervención con objeto de acudir a otro Psicólogo o profesional. En este último caso, el/la Psicólogo/a no podrá negarse a simultanear su intervención con otra diferente realizada por otro profesional.

52. Marta se recrimina el llorar con facilidad, Antonio le explica que esta conducta puede ser un recurso para afrontar el estrés. Según Holahan, Moos y Shaefer, la descarga emocional, (llorar y gritar), es una estrategia de afrontamiento del estrés de:

- a) Aproximación cognitiva.
- b) Aproximación conductual.
- c) Evitación cognitiva.
- d) Evitación conductual.

53. Antonio, evalúa el estilo parental de Marta y de su marido. Señala el criterio sobre parentalidad positiva que NO se recoge en el art. 26.3 a) de La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia:

- a) El comportamiento de los progenitores debe estar fundamentado en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia.
- b) El derecho del menor a expresar su opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten.
- c) La educación del menor en derechos y obligaciones, favorecer el desarrollo de sus capacidades, ofrecer reconocimiento y orientación, y permitir su pleno desarrollo en todos los órdenes.
- d) Los padres deben desarrollar competencias vinculares, formativas protectoras y reflexivas.

54. En el equipo interdisciplinar se han incorporado nuevas personas, Antonio observa que, si bien hay mucha motivación inicial, también están surgiendo tensiones y discusiones sobre roles, métodos de trabajo y la autoridad de la persona que coordina. Antonio necesita identificar esta fase para aplicar la estrategia de liderazgo adecuada. De acuerdo con el Modelo de las Cinco Etapas de Desarrollo de Equipos de Tuckman, ¿cuál es la fase que se caracteriza por una alta energía emocional, la aparición de conflictos interpersonales y la resistencia abierta o encubierta a la estructura, las reglas y la autoridad del líder?

- a) Normalización (*Norming*): El equipo establece cohesión, roles claros y normas operativas.
- b) Formación (*Forming*): El equipo muestra cortesía, gran dependencia del líder y confusión respecto a las tareas.
- c) Conflicto (*Storming*): El equipo experimenta la lucha por el poder, la confrontación de ideas y la gestión de la frustración.
- d) Desempeño (*Performing*): El equipo opera de manera autónoma, eficiente y enfocada en los resultados.

55. George y Gwyther (1986) consideran la sobrecarga de la persona cuidadora como el conjunto de problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos experimentados por una persona que realiza la tarea de cuidar. Existen muchos factores tanto internos como externos que influyen en la aparición de esta sobrecarga, entre los que NO se encuentran:

- a) Factores relacionados con el cuidador/a: Género, edad, nivel de estudios, personalidad, parentesco, salud, formas de afrontamiento, actividad laboral, nivel socioeconómico, etc.
- b) Factores relacionados con la persona con demencia: Género, edad, personalidad previa, nivel de deterioro cognitivo, discapacidad funcional, trastornos del comportamiento, pérdida del insight, años de evolución, etc.
- c) Factores relacionados con la familia: a mayor número de miembros de la familia que hayan presentado o presenten dependencia o discapacidad, menor capacidad de habilidades para el cuidado.
- d) Factores relacionales con el entorno: valores culturales, creencias religiosas, apoyo familiar, apoyo social, apoyo institucional, etc.

EJERCICIO PRÁCTICO EN EL PROCESO DE PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN PSICÓLOGA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

EJERCICIO PRÁCTICO (TIPO TEST)

SUPUESTO PRÁCTICO 2

En un Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Jaén, el equipo técnico ha detectado un aumento en las demandas relacionadas con conflictos intrafamiliares, sobrecarga de cuidados, aislamiento de personas mayores y violencia de género.

En los últimos días se han presentado tres situaciones que requieren valoración e intervención por parte del Equipo Interdisciplinar., en la que participa el/la psicólogo/a.

Caso 1: Conflicto familiar con menor en riesgo

Una madre de 45 años acude preocupada por su hijo adolescente de 15 años que ha comenzado a faltar al instituto, mantiene conductas desafiantes y pasa muchas horas con amigos mayores con consumo habitual de cannabis. La madre refiere sentirse desbordada, con escasos recursos económicos y sin apoyo familiar. El tutor del centro educativo ha derivado el caso por posible situación de riesgo.

Caso 2: Persona mayor en situación de aislamiento

Una vecina informa que D. Antonio, de 82 años, vive solo desde el fallecimiento de su esposa. Ha dejado de salir a la calle, no abre la puerta y apenas contesta al teléfono. El servicio de ayuda a domicilio ha notado un progresivo abandono personal y de la vivienda. No tiene hijos ni familiares cercanos en el municipio.

Caso 3: Mujer con discapacidad y posible violencia intrafamiliar.

Rosa, de 33 años, presenta una discapacidad física del 65 % provocada por un accidente laboral, la unidad familiar consta de Rosa, su marido y su hija de 3 años. Ha sido derivada a Servicios Sociales por la Trabajadora Social del Centro de Salud, debido a la atención frecuente por parte de los servicios sanitarios a su hija de 3 años.

En la primera entrevista Rosa refiere conflictos con su marido que pueden indicar una situación de maltrato, aunque Rosa no lo reconoce y lo justifica. Manifiesta sentimientos de culpabilidad, ansiedad y retraimiento social.

1. Según la Ley Orgánica 1/1996, 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 12), sobre actuaciones de protección, en los acogimientos permanentes, la revisión tendrá lugar:

- a) El primer año cada tres meses.
- b) A partir del segundo año, cada doce meses
- c) El primer año cada cuatro meses.
- d) A partir del segundo año, cada seis meses.

2. Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, Art. 35. En el ámbito educativo, con respecto a la figura del coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Los centros educativos, preferentemente los de titularidad pública, donde cursen estudios personas menores de edad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado.
- b) El/la coordinador/a actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.
- c) Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
- d) Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

3. Según la Ley 4/2021 de 27 de julio, de infancia y adolescencia en Andalucía, (art. 81), son criterios de actuación:

- a) Se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y escuchados solo en caso de mayores de 12 años, en la toma de decisiones que les afectan.
- b) La existencia de relaciones personales de la niña, niño o adolescente con su familia de origen no será impedimento para una posible propuesta de guarda con fines de adopción.
- c) Se garantizará el acceso a la información sobre los orígenes biológicos a las personas que hayan sido adoptadas, solo cuando alcancen la mayoría de edad. Asimismo, dispondrán de un servicio especializado de asesoramiento y ayuda.
- d) En el proceso de adopción de las medidas de protección, se evitará la participación y la colaboración de la familia de origen de la persona menor de edad en la toma de decisión.

4. En el III Plan de Juventud de la Diputación Provincial de Jaén, las actuaciones se articulan en torno a 5 ejes de intervención.

- a) Recursos para los municipios, Innovación, Participación, #Jaényomequedo, Prioridad juventud.
- b) Recursos para los jóvenes, Innovación, Sensibilización, #Jaényomequedo, Prioridad juventud.
- c) Recursos para los municipios, Innovación, Participación, #Jaényotequero, Prioridad juventud.
- d) Recursos para los niños, niñas y adolescentes, Innovación, Participación, #Jaényomequedo, Prioridad adolescencia.

5. La psicóloga del Equipo de Intervención Familiar, propone diseñar un proyecto para el desarrollo de competencias personales para trabajar con algunos miembros de familias del P.I.F (Programa Intervención Familiar) tomando como referencia el Modelo de Competencia Social de Gumpel. Este modelo engloba 6 áreas claves entre las que NO se encuentra:

- a) Habilidades de decisión.
- b) Juicios de monitorización personal.
- c) Habilidades de decodificación.
- d) Habilidades de concentración.

6. La psicóloga del Equipo de Intervención Familiar junto con sus compañeros/as consideran que la alianza de trabajo es una clave esencial del éxito en la intervención. Basándose en las 4 dimensiones del modelo S.O.A.T.I.F (Sistema de Observación de la Alianza Terapéutica en la Intervención Familiar); “Guía práctica para la intervención familiar” (Valentín Escudero) SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Enganche en el sistema familiar.
- b) Conexión emocional del usuario/a con el/la profesional.
- c) Seguridad en el sistema de intervención
- d) Sentido de compartir el propósito en la familia.

7. La psicóloga del Equipo de Intervención Familiar propone utilizar técnicas de terapias narrativas para reducir las resistencias de Rosa en la intervención, según la concepción constructivista de la narrativa (Bruner 1988). SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) El pensamiento narrativo está centrado en las emociones, los relatos, de ordenamiento intuitivo, imaginativo.
- b) El pensamiento narrativo, requiere referencias verificables y es de tipo digital.
- c) El pensamiento narrativo se desarrollaría según Bruner (1988) en el sujeto antes que el pensamiento paradigmático.
- d) El pensamiento narrativo es de tipo analógico, algunas de las técnicas que han dado buenos resultados son las metáforas para el acceso y simbolización de emociones.

8. Es frecuente en el trabajo con familias que los Equipos de Intervención Familiar se encuentren con dificultades o patologías relacionadas con la salud

mental y adicciones. Rosa manifiesta ansiedad y retraimiento social. En la clasificación de los trastornos de ansiedad, según el manual DSM-5, el trastorno por ansiedad social, considerando los factores de riesgo y pronóstico: SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Los rasgos subyacentes que predisponen a las personas al trastorno de ansiedad social son la inhibición del comportamiento y el miedo a la evaluación negativa.
- b) El maltrato infantil y la adversidad son factores de riesgo para el trastorno de ansiedad social.
- c) Los rasgos que predisponen a la ansiedad social, tales como la inhibición conductual no están influenciados genéticamente.
- d) El trastorno de ansiedad social es hereditario.

9. El equipo interdisciplinar, del que forma parte la psicóloga, se plantea realizar Programa de Intervención Familiar en varias familias con menores. Para ello revisan el manual vigente en la Diputación de Jaén, dicho P.I. F (Programa Intervención Familiar) se define como un programa:

- a) Específico de prevención primaria, dirigido a familias en situación de riesgo moderado.
- b) General de prevención secundaria, dirigido a familias para la reunificación familiar.
- c) Específico de prevención secundaria, con una intervención integral, planificada y consensuada.
- d) Uno de los objetivos es trabajar la reunificación familiar.

10. Rosa, ha sido derivada a Servicios Sociales Comunitarios por la trabajadora social del Centro de Salud, inicialmente se muestra esquivada no aceptando la derivación. Considerando el manual P.I.F (Programa Intervención Familiar), cuando una familia es derivada por un sistema o servicio distinto de Servicios Sociales Comunitarios y ésta se niega a aceptar la derivación, relacionado con buenas prácticas. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) El servicio/ sistema derivante convoca a la familia para una entrevista previa sin la presencia de Servicios Sociales Comunitarios.
- b) En el caso de que la familia abandone durante el proceso de intervención, se puede intentar el acercamiento, considerando el uso de técnicas narrativas, como la redacción de una carta personalizada de corte terapéutico.
- c) El servicio/sistema derivante convoca a la familia y a los Servicios Sociales Comunitarios para mantener una entrevista conjunta.
- d) Según propone Neuberger (1994) cuando un síntoma, sufrimiento y demanda no coinciden en el mismo sistema, la intervención ha de ser de carácter sistémico.

11. En los casos de familias con menores en riesgo (caso 1 y caso 3) con los que se encuentra el Equipo de Intervención Familiar, el instrumento para la

valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de infancia y adolescencia en Andalucía, es el VALÓRAME. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) La presencia de conciencia del problema y/o colaboración con la propuesta de intervención supondrá una disminución en el nivel de global de gravedad
- b) La nula o insuficiente conciencia del problema y/o colaboración con la propuesta de intervención podrá suponer un incremento en la valoración del nivel de gravedad del caso.
- c) La presencia de indicadores de riesgo leve sin que existan indicadores de gravedad moderada, elevada o muy elevada, supondrá la valoración global como riesgo de desprotección.
- d) Salvo excepciones debidamente argumentadas, la presencia simultánea de varios indicadores de gravedad moderada no incrementa el nivel de gravedad global del caso.

12. El Equipo de Intervención Familiar, ante las situaciones de dificultad que afectan a los menores en los casos 1) y 3), tiene que cumplimentar el VALÓRAME, en este instrumento, la valoración de la gravedad se concreta en la información referida a los últimos:

- a) 4 meses.
- b) 5 meses.
- c) 6 meses.
- d) 8 meses para mayores de 12 años.

13. En el caso de la madre preocupada por su hijo adolescente de 15 años, la psicóloga del equipo utilizará el cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) de Goodman (1997). SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Los cuestionarios de autoinforme para adolescentes contienen preguntas sobre 25 atributos, esta versión es adecuada para jóvenes de entre 11 y 16 años, dependiendo de su nivel de alfabetización y comprensión.
- b) Para la población general o de bajo riesgo psicosocial puede ser mejor utilizar una alternativa que divide en tres subescalas el S.D.Q: problemas internalizados, síntomas de externalización y la escala prosocial.
- c) Algunas de las versiones disponibles del SDQ contienen al final un suplemento del impacto que generan los problemas detectados.
- d) La suma de las puntuaciones de los síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad y falta de atención, problemas de relación entre iguales y comportamiento prosocial generará una puntuación total de dificultades (basada en 25 ítem).

14. La psicóloga, en el caso de Rosa, en la que se observan manifestaciones de ansiedad y retraimiento social, propone a su Equipo utilizar estrategias de intervención según la teoría polivagal (Porges) en la que cada circuito (vagal

ventral, vagal dorsal y sistema nervioso simpático) suministra regulación neuronal primaria de un estado concreto. SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA.

- a) La jerarquía autónoma, es el primer principio organizativo de la teoría polivagal.
- b) El circuito vagal dorsal debería de favorecer las conductas de conexión social.
- c) El sistema nervioso simpático favorece las conductas defensivas de movilización (lucha/huida).
- d) El circuito vagal dorsal, las conductas defensivas de inmovilización.

15. Señale la definición INCORRECTA, de las contempladas en el artículo 4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía:

- a) Discapacidad: la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
- b) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o por razón de su discapacidad.
- c) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
- d) Accesibilidad cognitiva: es aquella condición básica de accesibilidad y no discriminación que incluye ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal.

16. El Equipo interdisciplinar del centro ha de conocer que tendrán derecho a las prestaciones y servicios previstos en la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, las personas mayores de sesenta y cinco años que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Quienes tengan la consideración de españoles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- b) Extranjeros, apátridas, o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalucía, en los términos establecidos en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reciprocidad.

c) Los hijos e hijas de aquellas personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.

d) Aquellas que hayan cumplido los cincuenta años de edad, y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior a 65%.

17. No caracteriza al modelo de Atención Centrada en la Persona. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA:

a) La misión de los profesionales no es cuidar, sino apoyar los proyectos de vida sin facilitar la autodeterminación de cada persona como ser único.

b) Buscar nuevas formas de atención, donde las personas puedan elegir, opinar y tener control real sobre los asuntos que le afectan en su vida cotidiana.

c) Identificar y visibilizar las capacidades de las personas para intervenir desde éstas.

d) Conocer la biografía, preferencias y deseos de las personas, para convertirlas en los principales referentes de los planes de atención.

18. Un buen Plan de Atención Individualizada (PAI) NO debe concebirse como:

a) Individualizado: diseñado para cada una de las personas usuarias del servicio; y grupal, en tanto que debe satisfacer también las necesidades sociales de la persona.

b) Periódico, se desarrolla durante todo el tiempo de permanencia en el servicio.

c) Actualizado, debe permitir la comprobación de los cambios sufridos por el residente desde que se implantó el PAI.

d) Evaluable, con indicadores que permitan introducir mejoras en el proceso.

19. ¿Cuál de las siguientes escalas permite la evaluación de la calidad de vida en personas con discapacidad?

a) Escala de Zung.

b) Inventario ICAP.

c) Escala GENCAT.

d) Escala VINELAND.

20. La persona que conoce las necesidades, preferencias, deseos de la persona con discapacidad, intentando que sus expectativas sean satisfechas para favorecer su bienestar, y que interviene activamente en el Plan de Atención Individualizada o Plan Personal de Apoyos, en las reuniones para su diseño, seguimiento e implantación, sirviendo de cauce de comunicación de la persona usuaria con el equipo interdisciplinar, es:

a) Un miembro de su familia.

b) Un compañero o compañera de su unidad de convivencia.

- c) La figura del profesional de referencia.
- d) Un/a profesional de la Psicología o del Trabajo Social.

21. Para que Antonio pueda tener acceso a las prestaciones públicas, primero ha de ser valorada su situación de dependencia. Ésta podría clasificarse, según la Ley 39/2006, de 24 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ¿en qué grado?:

- a) Grado II. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, y además quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- c) Grado III. Dependencia grave: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total o parcial de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
- d) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

22. Según el documento técnico “Cuidado sin Sujeciones”, 2023, no existen razones que justifiquen el empleo de las sujeciones, pues atentan contra algunos de los principios éticos y jurídicos que deben regir las relaciones humanas, entre los que NO se encuentran:

- a) Principio de dignidad universal del ser humano.
- b) Principio de vulnerabilidad.
- c) Principio de tolerancia.
- d) Principio de diseño universal o diseño para todos.

23. Siguiendo el modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial de personas con necesidades complejas de apoyo, es común la existencia de instrumentos como el Comité de Ética Asistencial. ¿Cuál es la definición de este comité?:

- a) Instrumento que permite compartir un sistema de trabajo y de vida cotidiana

desde una perspectiva de los valores éticos de la institución.

- b) Instrumento que debe mencionar los derechos básicos de las personas usuarias, su significado y la necesidad de que sean el fundamento de la atención residencial.
- c) Instrumento que ayuda a identificar situaciones de riesgo y a promover formas de actuar fundamentadas en los principios éticos de la entidad que cubre las necesidades de apoyo.
- d) Instrumento que cuenta con equipos interdisciplinarios que dentro de una institución, reciben oficialmente el encargo de aconsejar a los profesionales y directivos en sus decisiones sobre cuestiones éticas planteadas en la práctica.

24. En un modelo de trabajo NO basado en el Modelo de Atención Centrada en la Persona:

- a) Las personas participan de manera exitosa en las actividades, aumentan las relaciones y la calidad de vida, y disminuyen las conductas desafiantes.
- b) El personal proporciona oportunidades y apoyo para que las personas con discapacidad participen. Siente más confianza en sí mismo y se ven como facilitadores.
- c) El personal trabaja bajo la convicción de que las personas con discapacidad necesitan usar conductas desafiantes para controlar el entorno.
- d) El entorno debe promover la participación y ha de ser psicológicamente comprensible, significativo y adaptado.

25. ¿En qué caso hablamos de calidad de vida en la atención residencial?

- a) Cuando el acompañamiento se fundamenta en la organización según dinámicas laborales, reparto de tareas, funciones y responsabilidades, con un buen convenio y organización temporizada.
- b) Cuando el trabajo está dedicado a la atención y prestación de servicios a la persona (alimentación, higiene, medicación...), y necesidades básicas funcionales (actividades básicas e instrumentales de la vida diaria).
- c) Cuando se rige por valores y criterios basados en la dignidad de la persona, en sus capacidades, creando un espacio personal significativo en el que se puede trabajar el proyecto de vida escogido por la persona, a partir de las costumbres personales y la situación anterior al ingreso.
- d) Cuando se trata de intervenciones protocolizadas que confieren calidad y confort, principalmente calidad asistencial en modo paternalista, sustituyendo habilidades que la persona puede hacer para evitarle así situaciones complejas que le lleven a un mayor deterioro.

26. ¿Qué es un Plan Personal de Apoyos?

- a) Es un proyecto basado en el grupo de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que las personas han aprendido para funcionar en su vida diaria y permite responder a las circunstancias cambiantes de la vida y a las exigencias contextuales.
- b) Es una herramienta que favorece la construcción de la identidad personal y facilita la comunicación de personas con discapacidad intelectual.

- c) Es un proceso que garantiza que la persona tenga poder efectivo en la toma de decisiones sobre su vida en una institución (centro residencial, piso tutelado, vivienda...), adaptando según sus decisiones los apoyos y actividades que precise y contando con apoyos que aseguren la continuidad y eficacia del mismo.
- d) Es una metodología que facilita a las personas, sobre la base de su historia, capacidades, deseos, y con ayuda de familiares, amigos o profesionales más significativos para él/ella, la identificación de las metas que quiere alcanzar para mejorar su vida.

27. Si estamos aplicando un programa de envejecimiento activo en el que trabajamos con enfermos de Alzheimer en sus estadios iniciales con el objetivo de intentar retrasar el desarrollo de la enfermedad, podemos decir que nuestra intervención se enmarca dentro de un programa de:

- a) Prevención Primaria.
- b) Prevención Secundaria.
- c) Prevención Terciaria.
- d) Ninguna de las anteriores al no ser un programa basado en la prevención.

28. De las dimensiones de calidad de vida desarrolladas por Shalock y Verdugo, ¿Cuál es la que se corresponde con la dimensión de Desarrollo Personal?

- a) La que tiene en cuenta las competencias y habilidades, la utilidad social, la participación en la elaboración del propio Plan Personal de Apoyos. El aprovechamiento de oportunidades y competencias personales, la conducta adaptativa y las estrategias de comunicación.
- b) La que tiene en cuenta sentimientos como la satisfacción personal y vital, el autoconcepto de sí mismo, así como la ausencia de estrés que contiene aspectos relacionados con la motivación, el humor, el comportamiento, la ansiedad y la depresión.
- c) La que se fundamenta en el proyecto de vida personal, en la posibilidad de elegir, en la que aparecen las metas y valores, las preferencias, objetivos e intereses personales.
- d) La que valora si se da rechazo o discriminación o aceptación por parte de los demás, si se utilizan entornos de desarrollo y ocio comunitario, si tiene amigos y redes de apoyo.

29. El Equipo de Servicios Sociales detecta que el hijo adolescente ha empezado a trapichear con porros y a jugar online con sus nuevas juntas. (Caso 1). En el tratamiento del juego patológico se utiliza, dentro de un programa de intervención más amplio, la exposición con prevención de respuesta. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- a) Antes de aplicar la exposición debe utilizarse el control de estímulos.
- b) Entrar cada día con un colega en los bares y locales de juego donde jugaba habitualmente.
- c) En los bares y locales de juego, puede consumir cualquier bebida.

- d) Después de aplicar la exposición debe utilizarse el control de estímulos.

30. El Equipo de Servicios Sociales habla con el chico adolescente y detecta uso abusivo del móvil. (Caso 1). En relación a las adicciones comportamentales en adolescentes, cuales son los principales problemas a la hora de intervenir, SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) La normalización generalizada entre la población joven de la conducta de juego.
- b) Las consecuencias negativas de la adicción no son percibidas como tales por el/la menor.
- c) El tratamiento más adecuado sería el formato grupal, complementándose con terapia individual y terapia familiar.
- d) La prevalencia entre estudiantes españoles entre 15 y 16 años que manifestaron tener problemas con redes sociales es superior en hombres respecto a mujeres, (EDADES 2020).

31. El Equipo de Servicios Sociales entrevista al chico de 15 años (caso 1), y se detecta alteración del sueño, elevado nivel de ansiedad e ideas delirantes de persecución, asociadas al incremento en el consumo de cannabis. Según la tipología de Ries, basada en la gravedad y curso del trastorno mental y del trastorno adictivo, en una primera aproximación, ¿dónde se derivaría un primer episodio psicótico en un consumidor habitual de cannabis?

- a) Tipología D Atención Primaria.
- b) Tipología A Red de Trastornos Adictivos.
- c) Tipología B Red de Salud Mental.
- d) Tipología C Ambas Redes.

32. El Equipo de Servicios Sociales (caso 1) observa en la madre un elevado nivel de estrés y decide darle algunas pautas. NO forma parte de los modelos teóricos de afrontamiento del estrés:

- a) Modelo transaccional de los estilos de afrontamiento de Lazarus y Folkman.
- b) Modelo del Síndrome General de Adaptación de Selye.
- c) Modelo de la demanda-control-apoyo social de Karasek.
- d) La teoría de Cognitiva de Beck.

33. (CASO 2) En relación a las fases en Psicodrama aplicado a intervenciones grupales, selecciona la afirmación CORRECTA:

- a) En la fase de dramatización, el terapeuta abre una ronda de preguntas y el grupo comparte las experiencias.
- b) Existen dos tipos de caldeamiento, inespecífico, se centra la atención en el grupo, se facilita la interacción, se disminuye la tensión, hasta que surge el clima emocional donde los/as miembros del grupo participan. Esto da paso al caldeamiento específico de donde surgirá el/a protagonista (tema o persona).

- c) En la dramatización el protagonista del conflicto elige la técnica para representar el conflicto.
- d) En la fase de compartir, el protagonista del conflicto puede llegar a un proceso de darse cuenta, integral y de forma espontánea, que le lleve a un proceso de resignificación, que trasciende lo intelectual.

34. (CASO 3) Según el Código Deontológico de Psicología, qué actuación de la Psicóloga del Equipo de Servicios Sociales NO sería correcta respecto al proceso de recogida de información:

- a) La información sólo puede comunicarse a terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de esta autorización.
- b) Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por un Juez, el sujeto evaluado, o sus padres o tutores no tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe Psicológico consiguiente.
- c) El sujeto de un Informe Psicológico no tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la Psicólogo/a.
- d) Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente.

35. (CASO 3). El Equipo de Servicios Sociales en la entrevista con Rosa quiere trabajar con los pensamientos que conectan con los síntomas de ansiedad y culpabilidad, NO forma parte de las técnicas cognitivas utilizadas en la terapia cognitiva:

- a) Reestructuración cognitiva.
- b) Entrenamiento autoinstruccional.
- c) Detección del pensamiento.
- d) Modelado participante.

36. El Equipo de Servicios Sociales detecta en Rosa creencias y valores respecto a los roles en la pareja que pueden favorecer una situación de maltrato. (CASO 3). Según Badós, en el marco de la Reestructuración Cognitiva, NO forma parte de las técnicas de identificación de supuestos y creencias:

- a) Hacer que el cliente analice sus imperativos internos.
- b) Prestar atención a las memorias informadas por el paciente de acontecimientos significativos en su infancia.
- c) Utilizar un cuestionario de actitudes o creencias disfuncionales.
- d) Role-playing.

37. (CASO 3) El Equipo de Servicios Sociales, trabaja la resistencia al cambio, a la hora de abordar los conflictos de Rosa con su marido, desde el enfoque

de La Entrevista Motivacional (Milner y Rollnik) ¿A qué estrategia nos referimos cuando el terapeuta ofrece un acuerdo inicial, pero con un leve cambio de dirección?:

- a) Devolución de los dos aspectos de la ambivalencia.
- b) Acuerdo con un giro.
- c) Reformulación.
- d) Cambio de tema.

38. (CASO 3) El Equipo de Servicios Sociales insiste a Rosa para que acuda al Centro de la Mujer, aunque ella no está muy convencida. Cuando en un conflicto motivacional, el/la terapeuta prescribe un patrón de conducta a seguir para la resolución de un problema, provocando comentarios de "no problema" por parte del/la paciente nos referimos a:

- a) La trampa de la confrontación-negación.
- b) La trampa del experto.
- c) La trampa de la culpa.
- d) La trampa del etiquetaje.

39. (CASO 3). El Equipo de Servicios Sociales considera que si hubieran detectado la situación de Rosa durante su embarazo, se le habría propuesto desde pediatría su inclusión en "El Programa Nurse-Family Partnership". Este programa está diseñado para intervenir desde la fase prenatal, con madres embarazadas con factores de riesgo, y que continúa hasta que el niño/a cumple dos años. La intervención se centra en mejorar la salud, el desarrollo de madres e hijos y sus perspectivas vitales futuras. Es un programa de:

- a) Prevención Universal.
- b) Prevención selectiva.
- c) Prevención indicada.
- d) No es un programa preventivo.

40. El Equipo Interdisciplinar atiende casos complejos que requieren coordinación entre distintas áreas. La intervención debe ser coherente y abordar todas las dimensiones de la problemática. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, y dada la necesidad de abordar de forma conjunta las problemáticas sociales, económicas y personales de los casos 1, 2 y 3, ¿cuál de los siguientes es un principio específico de los servicios sociales en Andalucía que guía este enfoque global?

- a) Subsidiariedad respecto a la sanidad.
- b) Intervención mínima y sectorial.
- c) Integralidad de las actuaciones.
- d) Carácter discrecional de las prestaciones.

41. El CASO 2 podría requerir la activación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Antonio, como profesional, debe conocer la estructura de coordinación interterritorial de este sistema. En el marco de la

Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué figura jurídica se crea para coordinar las políticas y garantizar la equidad territorial en la aplicación de las prestaciones en todo el Sistema Nacional?

- a) Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- b) Consejo General de Servicios Sociales.
- c) Comité Consultivo Interadministrativo.
- d) Consejo Económico y Social.

42. (CASO 3). Rosa presenta indicios de maltrato intrafamiliar. El/la Psicólogo/a debe asegurar que su intervención y la comunicación del riesgo se enmarquen en la definición legal de la violencia de género. Según la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál es el ámbito objetivo de aplicación que define los actos de violencia incluidos en la Ley?

- a) Violencia física, psicológica y sexual.
- b) Violencia física, psicológica, sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad.
- c) Exclusivamente violencia acreditada con sentencia judicial firme.
- d) La violencia ejercida en el ámbito doméstico y en el entorno de convivencia.

43. El/la Psicólogo/a debe evaluar a Rosa (CASO 3) para identificar la psicopatología asociada al maltrato y descartar otros trastornos de personalidad que pudieran influir en su justificación de la violencia. El MMPI-2 es un test esencial en la evaluación forense y clínica. ¿Cuál es el objetivo psicométrico primordial de este instrumento?:

- a) Evaluar la memoria a corto plazo.
- b) Medir rasgos y psicopatología de la personalidad.
- c) Detectar la inteligencia emocional.
- d) Diagnosticar directamente la esquizofrenia.

44. En la intervención psicológica con Rosa (CASO 3), se requiere una planificación terapéutica estructurada para el trauma complejo asociado a una relación abusiva. En la intervención psicológica con víctimas de trauma complejo (como la violencia de género), el modelo de fases de recuperación de Judith Herman es un referente. ¿Cuál es la secuencia correcta de las tres fases que plantea este modelo?

- a) Fase de supervivencia → Dependencia → Autonomía.
- b) Fase de seguridad → Rememoración → Reconexión.
- c) Fase de evitación → Aceptación → Afrontamiento.
- d) Fase de afrontamiento → Recaída → Estabilización.

45. Rosa (CASO 3) presenta sintomatología que puede solaparse (ansiedad, retraimiento social, culpa). Antonio debe realizar un diagnóstico diferencial entre Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Depresión Mayor para un tratamiento focalizado. En la evaluación de Rosa, ¿cuál de los siguientes es el indicador clínico esencialmente diferencial entre un Trastorno de Estrés

Postrauumático (TEPT) por violencia de género y un diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor?

- a) Presencia de anhedonia.
- b) Intrusiones y reexperimentación del trauma.
- c) Fatiga y sentimientos de inutilidad.
- d) Alteraciones del sueño.

46. El/la Psicólogo/a debe evaluar al menor del CASO 1 para identificar las secuelas de la exposición a la violencia/conflicto. Se requiere una herramienta psicométrica validada para el *screening* de síntomas de trauma infantil. Para la exploración sistemática de la sintomatología postraumática en menores expuestos a la violencia, ¿cuál de las siguientes herramientas de detección conductual es la más recomendada y específica?

- a) Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC)
- b) MMPI-2
- c) Test de Apercepción Temática del Trauma (TAT)
- d) Escala Hamilton de Depresión

47. El/la Psicólogo/aes parte de un Equipo Interdisciplinar. Debe conocer los modelos de desarrollo grupal para optimizar la coordinación y gestión interna. El modelo de Cinco Etapas del Desarrollo de un Grupo de Tuckman (1965) describe la evolución típica de los equipos. ¿Cuál de las siguientes fases NO pertenece a dicho modelo?

- a) Formación (*Forming*)
- b) Confusión (*Confusing*)
- c) Normatividad (*Norming*)
- d) Desempeño (*Performing*)

48. El/la Psicólogo/a diseña una intervención grupal con Rosa (CASO 3) para trabajar habilidades de asertividad y practicar estrategias de comunicación con su hijo. En el diseño de talleres psicoeducativos sobre violencia de género o conflicto familiar, la técnica del *role-playing* (juego de roles) se utiliza principalmente para:

- a) Medir la inteligencia social.
- b) Desarrollar empatía y ensayar conductas alternativas ante el conflicto.
- c) Evaluar el liderazgo grupal.
- d) Promover la competencia entre participantes.

49. El/la Psicólogo/a busca un modelo que optimice el liderazgo de la persona que coordina, reconociendo que no todos las personas que integran el equipo tienen el mismo nivel de experiencia o motivación en todas las tareas: ¿Cuál de los siguientes modelos de liderazgo postula que la efectividad del líder no depende de un estilo fijo, sino que su enfoque debe ajustarse a la 'madurez' o nivel de sus componentes para realizar una tarea específica?

- a) La Teoría del Intercambio Líder-Miembro (LMX)
- b) El Liderazgo Transaccional

- c) La Teoría del Liderazgo de Fiedler (Modelo de Contingencia)
- d) El Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard

50. En el CASO 2, D. Antonio, 82 años, presenta indicadores de soledad no deseada y posible deterioro funcional o cognitivo. El equipo interdisciplinar busca una estrategia para romper el aislamiento y movilizar recursos. Para la intervención inicial, la estrategia más adecuada desde la Psicología Comunitaria para movilizar los recursos de apoyo, reducir el aislamiento y evaluar el deterioro funcional de D. Antonio es:

- a) Iniciar inmediatamente un proceso judicial para la incapacitación legal de D. Antonio.
- b) Proporcionar un diagnóstico clínico de depresión mayor basado solo en la información de la vecina.
- c) Aplicar una Intervención de Proximidad, movilizando recursos de la red primaria (voluntariado, teleasistencia) y realizando una visita domiciliaria para una valoración funcional y cognitiva (*in situ*).
- d) Recomendar el ingreso en un centro residencial como única medida de protección.

RESERVAS

51. El grupo de Servicios Sociales detecta que Antonio (caso 2) mantiene un duelo patológico desde el fallecimiento de su mujer. Antonio acepta derivación a Salud Mental. La psicóloga de salud mental lo incluye en un grupo de duelo que trabaja con técnicas del psicodrama. ¿Cuáles son los cinco elementos principales de un psicodrama?

- a) Escenario, protagonista, terapeuta, yo/es auxiliares y público o grupo.
- b) Escenario, protagonista, familia, director y coro.
- c) Protagonista, director, personajes secundarios, terapeuta y coro.
- d) Escenario, sociograma, caldeamiento, dramatización y compartir.

52. En los casos de familias con menores en riesgo, resulta esencial la valoración del apego. Según Jorge Barudy, “Guía de evaluación de las competencias y la resiliencia parental”, en la evaluación del apego adulto, y en relación a la valoración de la salud mental de los padres y problemas personales que pueden afectar positiva o negativamente la relación con sus hijos e hijas, se distinguen varias áreas. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a) Área 1: recursos personales que influyen las competencias parentales.
- b) Área 2: trastornos y problemas de comportamiento que afectan las competencias parentales.
- c) Área 3: Efectos de los diferentes trastornos de la personalidad de los padres en sus competencias parentales.
- d) Área 4: efectos de la resiliencia parental que influyen las competencias parentales.

53. (Caso 1), ¿Qué afirmación respecto a los modelos de abordaje en patología dual es INCORRECTA?:

- a) Modelo de cuidado escalonado: profesionales de salud mental son invitados a dispositivos de drogodependencias y viceversa, al paciente se le trata en un único dispositivo con un único plan terapéutico.
- b) Modelo paralelo: el paciente es atendido en ambos dispositivos de forma simultánea e independiente.
- c) Modelo integrado: el mismo equipo de un recurso asistencial oferta un tratamiento tanto para la adicción como para la comorbilidad psiquiátrica.
- d) Modelo secuencial: el paciente es atendido inicialmente en función de la patología que se considera primaria por el tipo de recurso destinado a ello. Solo cuando el paciente está estable o asintomático es derivado al siguiente dispositivo.

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la discapacidad es falsa?

- a) La discapacidad afecta tanto a la dinámica familiar como a la calidad de vida de cada uno de sus miembros. (Ortega, torres, Garrido y Reyes, 2006).
- b) La forma en que los profesionales comunican a la familia el diagnóstico de discapacidad tiene una gran influencia en las impresiones, reacciones iniciales y posterior desarrollo del niño o niña y de la familia. (Madrigal, 2007).
- c) Es de vital importancia que se trabaje con todos los integrantes de la familia, con esto se obtendrá una mejor calidad de vida para todos los miembros, además de que la familia aprenderá a convivir con la persona con discapacidad y comprenderán que necesita cuidados especiales y sobreprotección. (Rossel, 2004).
- d) La intervención con familias tiene un carácter interdisciplinar, logrando así que las familias sean más eficaces y capaces de asumir el cuidado responsable de su familiar, facilitando así su adaptación, reduciendo su vulnerabilidad y potenciando sus recursos. (Ortiz, 2007).

55. Si El/la Psicólogo/a decide aplicar una prueba de inteligencia al menor del CASO 1 para entender su rendimiento escolar, necesita interpretar la puntuación típica del Cociente Intelectual. En la interpretación psicométrica de un Cociente Intelectual (CI), la puntuación típica se transforma para establecer una media de 100 y una desviación típica de 15. ¿A qué tipo de escala corresponde esta puntuación?

- a) Una distribución normal estándar transformada.
- b) Una escala ordinal no comparable.
- c) Una medida de validez interna.
- d) Un índice no interpretable sin entrevistas adicionales.

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN PSICÓLOGA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PLANTILLA DE RESPUESTAS EJERCICIO PRÁCTICO

SUPUESTO UNO

1	B	31	B
2	C	32	B
3	C	33	C
4	A	34	B
5	D	35	A
6	A	36	A
7	C	37	A
8	B	38	B
9	D	39	A
10	A	40	B
11	B	41	C
12	D	42	C
13	C	43	B
14	A	44	B
15	B	45	A
16	C	46	A
17	D	47	A
18	C	48	B
19	B	49	B
20	B	50	B
21	D	RESERVAS	
22	B	51	D
23	C	52	D
24	C	53	D
25	D	54	C
26	B	55	C
27	D		
28	C		
29	B		
30	A		

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/nUw6JKzHyAHmc8l3nLERg==>

FIRMADO POR	JUANA GARCÍA LEON - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	FECHA Y HORA	11/11/2025 12:40:12
FIRMADO POR	JAVIER MUÑOZ ENDRINO - EL SECRETARIO DE TRIBUNAL	FECHA Y HORA	11/11/2025 12:29:14
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	nUw6JKzHyAHmc8l3nLERg==	EV00YAKV
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		



SUPUESTO DOS

1	B	31	D
2	A	32	D
3	B	33	B
4	A	34	B
5	D	35	D
6	A	36	D
7	B	37	B
8	C	38	A
9	C	39	B
10	A	40	C
11	A	41	A
12	C	42	B
13	D	43	B
14	B	44	B
15	D	45	B
16	B	46	A
17	A	47	B
18	A	48	B
19	C	49	D
20	C	50	C
21	D	RESERVAS	
22	C	51	A
23	D	52	D
24	C	53	A
25	C	54	C
26	C	55	A
27	B		
28	A		
29	A		
30	D		

Se concede a los/as aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, a los efectos de la formulación de alegaciones/reclamaciones.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/nUw6JKzHyAHmc8I3nLERg==			
FIRMADO POR	JUANA GARCÍA LEON - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	FECHA Y HORA	11/11/2025 12:40:12
FIRMADO POR	JAVIER MUÑOZ ENDRINO - EL SECRETARIO DE TRIBUNAL	FECHA Y HORA	11/11/2025 12:29:14
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	nUw6JKzHyAHmc8I3nLERg==	EV00YAKV
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electr?nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr?nica.		

